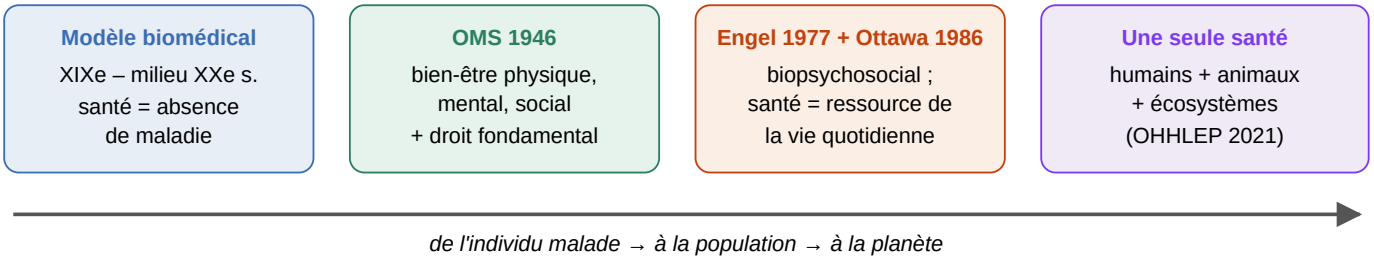
Les schémas du chapitre 1 à savoir refaire

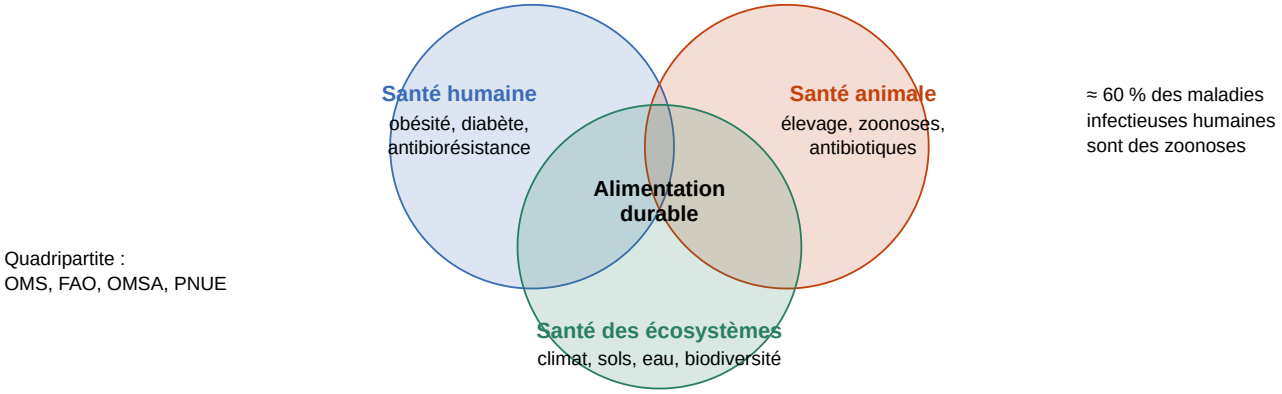
17 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

1. L'évolution des concepts de santé (1.3.1, figure 1.1)



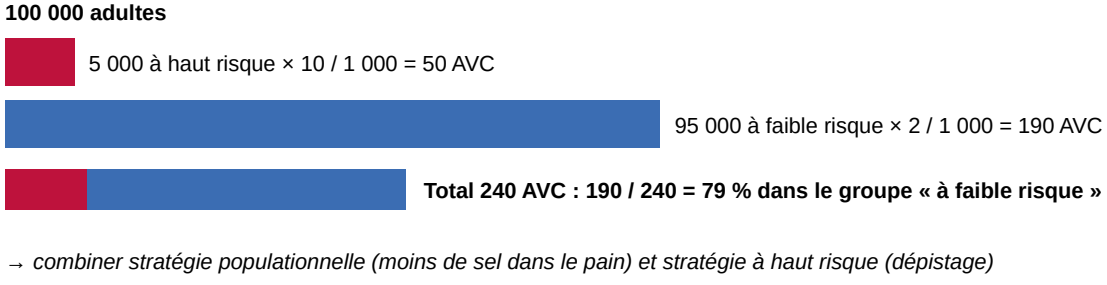
Dire : définition négative → positive et multidimensionnelle → ressource dépendant des déterminants → santé humaine indissociable de l'animal et de l'environnement. Citer la critique du « complet » bien-être.

2. Une seule santé (One Health) (figure 1.2)



Exemple à donner : menu végétarien hebdomadaire (EGalim) = plus de fibres (humain), moins de gaz à effet de serre (écosystèmes), moins de pression sur l'élevage (animal). Guide BTS 2025 : toute action BC3 s'inscrit dans « Une seule santé ».

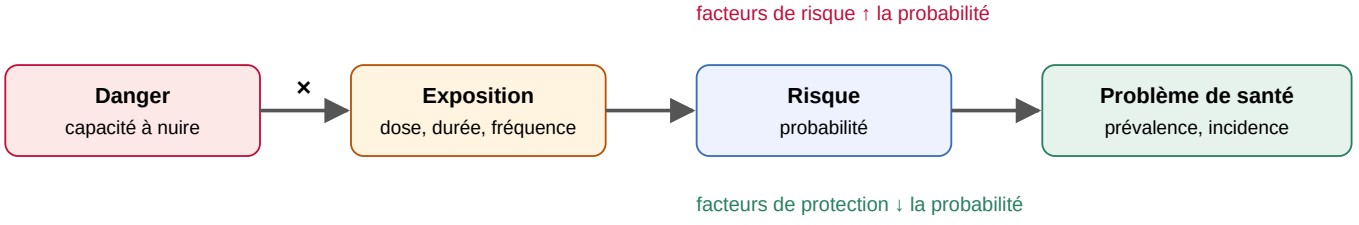
3. Le paradoxe de la prévention de Rose (1985) (1.3.2)



→ *combiner stratégie populationnelle (moins de sel dans le pain) et stratégie à haut risque (dépistage)*

Phrase clé : « un grand nombre de personnes exposées à un petit risque produit plus de cas qu'un petit nombre exposé à un risque élevé ». Calcul : cas = effectif × taux / 1 000 ; part = cas du groupe / total × 100.

4. Du danger au problème de santé : la chaîne du risque (figure 1.3 bis)



Risque = danger × exposition. Un facteur de risque est une association statistique, pas forcément une cause (critères de Bradford Hill).

5. Les 4 modes d'intervention du guide 2025 (figure 1.3)



L'ETP relève du soin (BC1), pas de l'éducation pour la santé

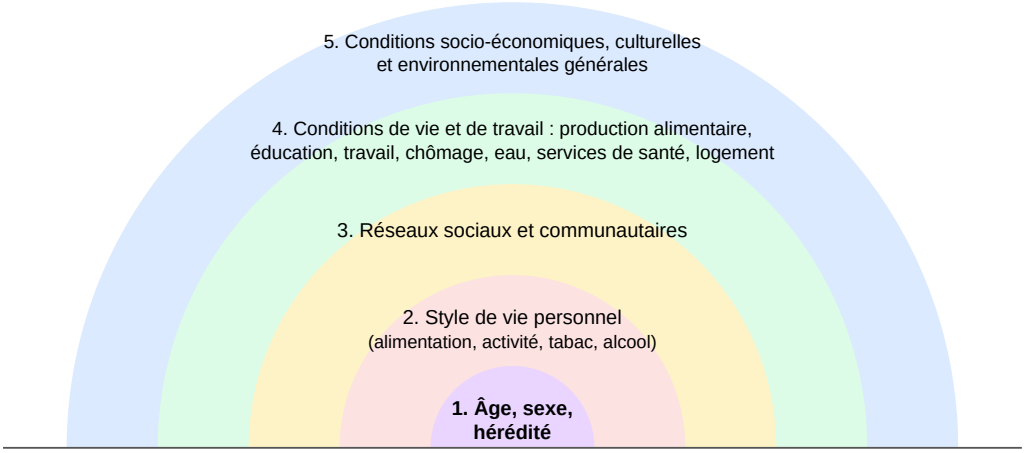
> Le CNED ajoute la sécurité sanitaire (veille → expertise → gestion → communication) et la restauration de la santé (soin, hors BC3). À l'examen, qualifier son action avec les 4 modes du guide.

6. La Charte d'Ottawa : 5 domaines + 3 stratégies (figure 1.4)



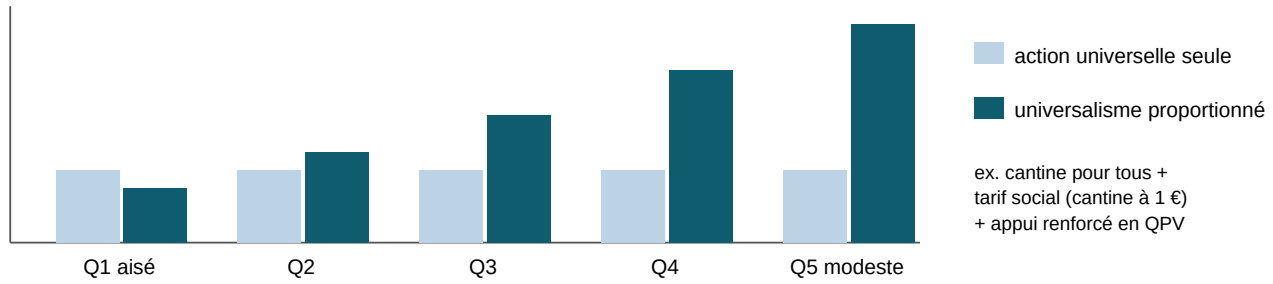
> Définition : « processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci ». Donner un exemple nutrition par domaine.

7. Les déterminants de la santé (Dahlgren et Whitehead, 1991) (figure 1.5, numérotés du centre vers l'extérieur)



> Lecture : plus on agit sur les couches extérieures (prix, offre, revenus), plus on touche de monde et on réduit les inégalités ; agir seulement au centre (« manger mieux ») a un effet limité. Détaillé au chapitre 2.

8. L'universalisme proportionné (Marmot, 2010) (figure 1.6)



Pour tous, avec une intensité proportionnelle au désavantage social. Évite deux écueils : l'universel seul profite aux plus favorisés ; le ciblé seul stigmatise et oublie le gradient social.

9. Les niveaux de prévention : OMS (1948) et Gordon (1983) (figure 1.7)

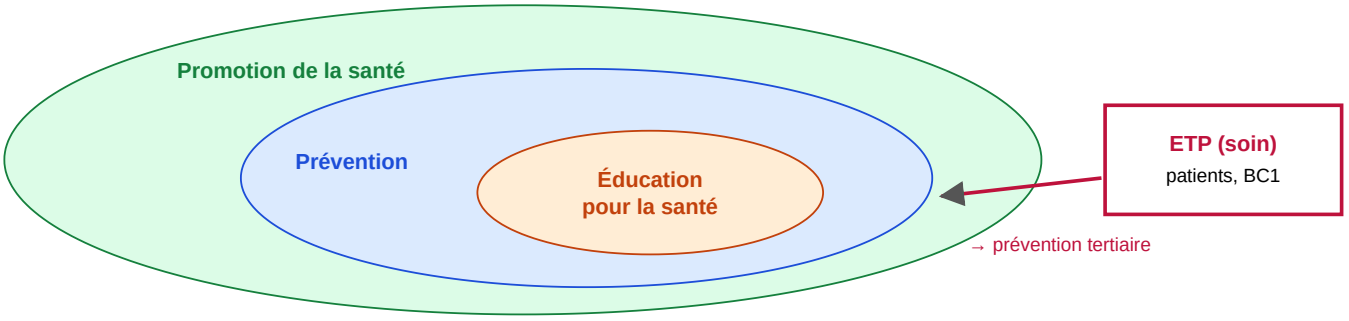
Bonne santé	Facteurs de risque / début	Maladie installée	Complications
Primaire ↓ incidence repères PNNS, atelier	**Secondaire** ↓ prévalence, dépistage dénutrition en EHPAD	**Tertiaire** ↓ complications, récidives ETP diabète (BC1)	**Quaternaire** Jamoulle 1986 éviter la surmédicalisation

Gordon (selon le public, classification indépendante) :

Universelle	Sélective	Indiquée
toute la population	sous-groupe exposé, sans signe	facteurs de risque déjà présents

Pièges : le dépistage est secondaire ; la primaire baisse l'incidence, la secondaire la prévalence ; les cases de Gordon ne correspondent pas aux colonnes de l'OMS.

10. Emboîtement : promotion, prévention, éducation pour la santé, ETP (figure 1.8)



Promotion = la plus large (déterminants, politiques) ; prévention = un problème défini ; éducation pour la santé = un moyen des deux, pour des personnes bien portantes ; ETP = patients atteints de maladie chronique, programme déclaré à l'ARS (loi HPST 2009).

11. Les 4 types d'acteurs (CNED) (figure 1.8 bis)

Décideurs
Parlement, DGS, DGAL, ARS, département, commune

Consultatifs
HCSP, CNS, CNA, CRSA, conseils territoriaux

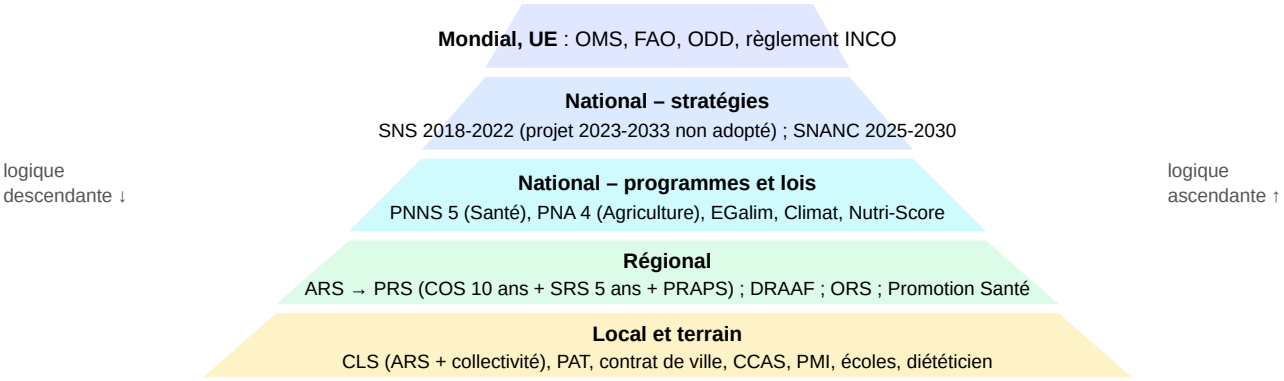
Politique de santé publique

Opérateurs
Santé publique France, CCAS, PMI, associations, diététiciens

Financeurs
ARS (FIR), Assurance maladie (FNPEIS), collectivités, mutuelles, fondations

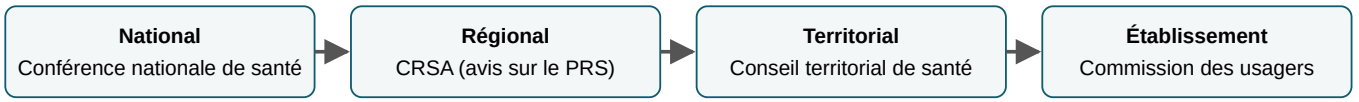
Un acteur peut avoir deux rôles (l'ARS décide et finance). Pour un projet de stage : au moins un acteur de chaque type. Calcul fréquent : part d'un financeur = montant / budget total × 100.

12. Architecture des politiques nutritionnelles en 2026 (figure 1.9, corrigée)



À l'oral : relier son action locale à chaque niveau (« axe … du PNNS 5, objectif … du PRS, fiche-action … du CLS »). La SNANC détermine les orientations du PNNS et du PNA.

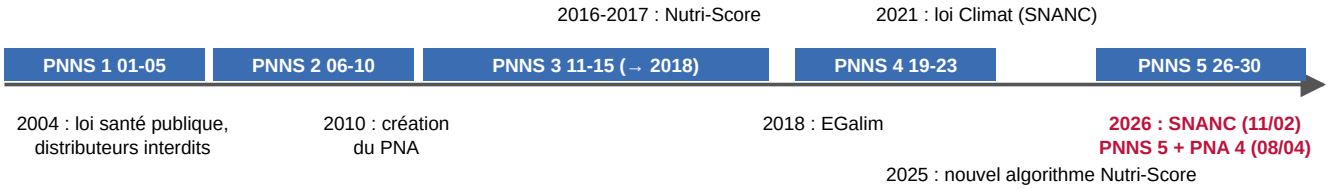
13. Les instances de la démocratie sanitaire (figure 1.8 ter)



Loi Kouchner du 4 mars 2002 : droits individuels (information, consentement, accès au dossier) et droits collectifs (représentation par des associations agréées ; France Assos Santé, 2016)

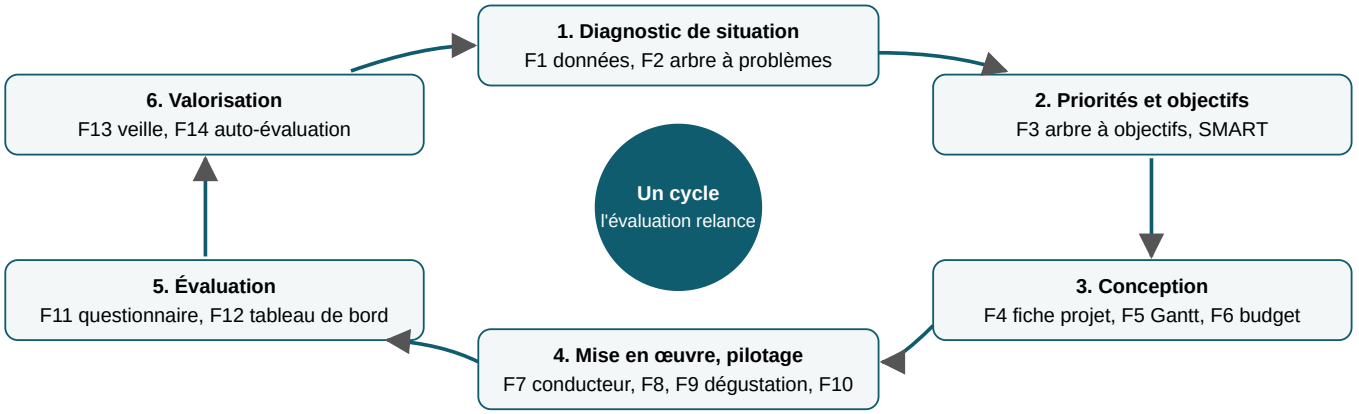
Pour le diététicien : la démocratie sanitaire justifie la participation des habitants (« j'ai associé deux mères de famille au comité de pilotage »).

14. Frise des politiques nutritionnelles 2001-2026 (figure 1.10 bis)



Évolution : d'une politique de messages (PNNS 1) à une action sur l'environnement alimentaire et le climat. PNNS 5 : 3 axes, 20 mesures, − 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants (− 20 % chez les plus défavorisés).

15. La démarche de projet et les fiches F1 à F14 (figure 1.11)



Projet (Afnor) ⊃ action ⊃ atelier : un atelier isolé n'est pas un projet. SMART = Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel. Objectif général → spécifiques → opérationnels.

16. Les 4 types de besoins de Bradshaw (1972) (figure 1.11 bis)

Normatif
défini par un expert selon une norme
ex. perte de poids ≥ 5 % en un mois (HAS 2021)

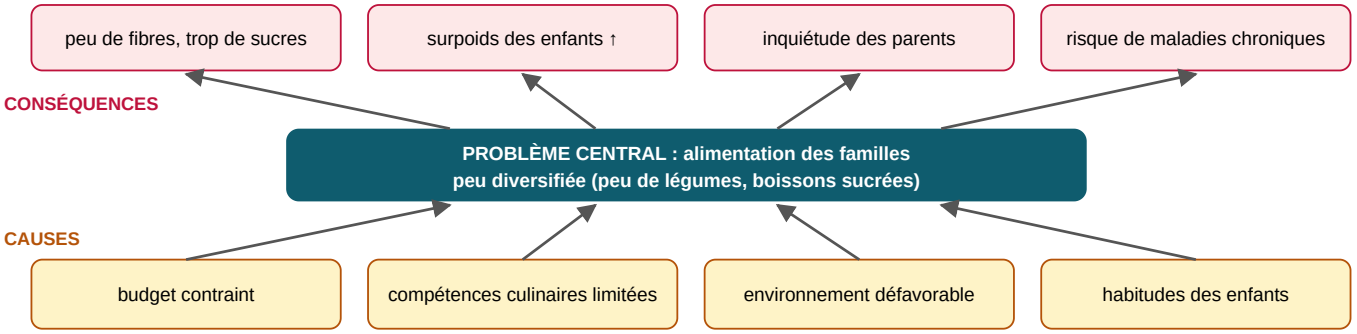
Ressenti
perçu par la population, pas forcément dit
ex. « je n'ai plus envie de cuisiner seule »

Exprimé
ressenti devenu demande
ex. 12 résidents demandent des repas variés

Comparatif
comparaison avec un groupe déjà servi
ex. la résidence voisine a un repas partagé

> Un besoin présent dans plusieurs cases est prioritaire. Erreur classique : « besoins ressentis par les professionnels » (c'est normatif ou observé).

17. Arbre à problèmes (fil rouge) (figure 1.12)



> Causes en bas (racines), conséquences en haut (branches). L'arbre à objectifs (F3) transforme chaque cause en objectif positif ; on choisit les causes sur lesquelles on peut agir (compétences, habitudes, accès), et on plaide pour les autres (revenus).